

Carta Editorial - Federalismo e a política de oferta de serviços de saúde

Parecer editorial

Federalismo e a política de oferta de serviços de saúde

Manuscrito: Pedroso 2026, “Federalismo e a política de oferta de serviços de saúde: diferentes estados, diferentes padrões de oferta?”

Data: 15 de maio de 2026

Formato: Carta editorial consolidada com dois pareceres independentes.

Carta Editorial

Decisão Revise & Resubmit (major)

Síntese

Os dois pareceristas concordam que o manuscrito tem uma contribuição empírica promissora: uma série longa UF-ano sobre provisão estadual de serviços de saúde e um achado substantivo relevante para a literatura de federalismo, saúde e desigualdades territoriais. O resultado central — convergência no peso relativo dos estados e divergência na composição da oferta — é interessante e pode gerar uma contribuição forte. No entanto, ambos entendem que o paper ainda precisa de revisão substantiva antes de circular como artigo de alto nível. O Parecerista 1 enfatiza que a contribuição teórica e o mecanismo causal estão subdesenvolvidos; o Parecerista 2 enfatiza que o desenho atual é essencialmente descritivo e não sustenta a linguagem causal usada em várias passagens.

Pontos de consenso entre pareceristas

- O painel UF-ano e o foco em provisão concreta de serviços são contribuições empíricas valiosas.

- O paper deve explicitar melhor o que está medindo: presença estadual, composição da rede, variação territorial, desigualdade, especialização e oferta não são conceitos intercambiáveis.
- A linguagem causal precisa ser calibrada. Se o artigo continuar descritivo, deve evitar afirmar que o SUS ou os incentivos federais “produziram” os padrões observados sem estratégia de identificação.
- O mecanismo precisa sair da conclusão e entrar no argumento teórico: coordenação federal, municipalização, capacidade fiscal, custos diferenciados e complementaridade com redes municipais devem orientar as expectativas antes dos resultados.
- A harmonização AMS-CNES e a classificação das macrocategorias são centrais para a credibilidade do artigo e precisam de documentação técnica e testes de sensibilidade.
- Há problemas formais a corrigir: inconsistências temporais, numeração repetida de gráficos, terminologia instável e referências citadas que parecem faltar na bibliografia.

Pontos divergentes

- Não há divergência substantiva forte entre os pareceristas; eles diagnosticam problemas complementares.
- O Parecerista 1 vê o principal gargalo na ambição teórica: o caso brasileiro precisa ser mobilizado como teste de um argumento mais geral sobre federalismo multidimensional.
- O Parecerista 2 vê o principal gargalo na inferência: o paper precisa escolher entre assumir uma contribuição descritiva rigorosa ou propor um desenho causal compatível com suas alegações.
- Como editor, eu daria prioridade conjunta a esses pontos: o artigo só ficará forte se a narrativa teórica e o desenho empírico forem alinhados ao mesmo nível de ambição.

Prioridades para revisão

1. **Reformular a pergunta e a contribuição.** A pergunta deve sair do nível “o que aconteceu no SUS brasileiro?” e se tornar uma pergunta mais geral sobre quando federações centralmente coordenadas produzem convergência em algumas dimensões da política pública e diferenciação em outras.
2. **Escolher a ambição inferencial.** Se o paper for descritivo, retire linguagem causal forte e apresente os padrões como fatos estilizados. Se quiser sustentar causalidade, especifique um estimando e uma estratégia de identificação compatível.
3. **Desenvolver uma seção teórica com mecanismos e hipóteses.** As quatro hipóteses hoje apresentadas na conclusão devem orientar o argumento: coordenação federal da atenção primária, acúmulo de instrumentos, custo/capacidade fiscal e complementaridade com redes municipais.

4. **Fortalecer mensuração e robustez.** Documente o crosswalk AMS-CNES, quantifique missings, justifique categorias ambíguas, teste classificações alternativas e rode sensibilidades para distância de Manhattan, categorias comparáveis e exclusão de casos influentes.
5. **Revisar apresentação e consistência.** Padronize o período de análise, corrija a numeração dos gráficos, estabilize os conceitos de oferta/provisão/gestão/titularidade e inclua apêndice replicável com fontes, código e decisões de harmonização.

Parecer completo — Parecerista 1 (Teoria & Substância)

Recomendação: R&R major

Resumo do paper

O artigo analisa como a oferta estadual de serviços de saúde no Brasil variou entre UFs de 1976 a 2025, distinguindo duas dimensões: o peso relativo dos estados na provisão pública e a composição dos serviços ofertados. O principal achado é ambivalente: o SUS teria uniformizado territorialmente a redução da presença estadual, mas aumentado a diferenciação entre estados no pacote de serviços.

Avaliação geral

O paper tem uma contribuição empírica promissora: constrói uma série longa e rara sobre provisão estadual de serviços de saúde e identifica um fato substantivo interessante para a literatura de federalismo, saúde e desigualdades territoriais. O ponto forte é mostrar que “uniformização” e “diferenciação” podem coexistir dentro de uma mesma política, dependendo da dimensão observada. O problema central, para um top journal, é que a contribuição teórica ainda está subdesenvolvida. O paper descreve bem um padrão, mas ainda não explica suficientemente por que esse padrão importa para teorias de federalismo, descentralização e provisão de welfare state. A própria introdução reconhece que o artigo “não explora os mecanismos explicativos”, e isso limita bastante sua força como contribuição teórica.

Comentários maiores

1. **A pergunta ainda está formulada muito próxima do caso brasileiro.** A pergunta central é relevante, mas aparece como: com o SUS, os padrões de descentralização e o pacote de serviços ofertados pelos estados se tornaram mais homogêneos ou heterogêneos? Isso é uma boa pergunta empírica, mas ainda não é a melhor pergunta teórica. Uma formulação mais forte seria algo como: *quando sistemas federativos centralmente coordenados produzem convergência territorial em algumas dimensões da provisão pública e divergência em outras?* O Brasil entraria, então, como

caso especialmente informativo de uma federação com forte coordenação federal, universalismo constitucional e três níveis de governo.

2. **A contribuição marginal precisa ser explicitada com mais precisão.** O paper sugere que a literatura brasileira enfatizou desigualdades fiscais, cobertura, acesso e resultados, mas não a composição concreta da oferta estadual. Esse é um bom gap. Mas o autor precisa dizer se sua contribuição é: uma nova medida, uma nova evidência descritiva, uma revisão da interpretação sobre o SUS, ou uma teoria sobre federalismo multidimensional. Minha sugestão é assumir uma contribuição combinada: descritiva e teórica. A formulação promissora é: a centralização federal pode padronizar “quem faz” uma política, sem padronizar “o que exatamente é feito” pelos entes subnacionais.
3. **O mecanismo causal está implícito, não articulado.** O paper afirma que incentivos federais reduziram o peso relativo dos estados e que a composição da oferta se diferenciou. Mas o elo causal entre desenho federativo, normativas federais, incentivos fiscais, capacidade estadual, lacunas municipais e especialização de serviços precisa aparecer antes dos resultados, não apenas como agenda futura na conclusão. O autor deveria transformar as quatro hipóteses finais em uma seção teórica: coordenação federal da atenção primária, layering de instrumentos, custo diferenciado dos serviços e complementaridade com redes municipais.
4. **As hipóteses não derivam de modo suficientemente lógico do argumento.** Hoje a expectativa geral é: centralização decisória deveria produzir homogeneidade, mas restrições de self-rule não implicam uniformização em todos os indicadores. Isso é correto, mas genérico. O paper precisa derivar hipóteses separadas: uma para convergência no nível de estadualização; outra para divergência na composição; e, idealmente, hipóteses sobre quais tipos de serviço deveriam gerar mais diferenciação. Por exemplo: serviços mais caros, especializados ou dependentes de capacidade instalada deveriam variar mais entre estados do que serviços mais padronizados por normas federais.
5. **O conceito de “variação” precisa ser separado de “desigualdade”.** O artigo é cuidadoso ao dizer que composição da oferta não é necessariamente uma dimensão normativa de bem-estar, mas ainda se apoia muito na literatura de desigualdade territorial. Isso cria ambiguidade: diferenciação entre estados é problema, adaptação eficiente a necessidades locais, complementaridade federativa ou apenas heterogeneidade administrativa? O paper ganharia muito se distinguísse conceitualmente variação, desigualdade, especialização e fragmentação. A implicação teórica depende dessa distinção.
6. **Os estados precisam aparecer como atores, não apenas como unidades de medida.** O texto revisa bem o debate sobre fragilidade decisória dos estados, mas a análise ainda trata os estados quase como recipientes de normas federais. Se a composição da oferta diverge, é preciso teorizar se isso vem de escolhas dos governos estaduais, capacidades burocráticas, legados institucionais, pressão de necessidades epidemiológi-

cas, coordenação regional, ou resposta a lacunas municipais. Sem isso, a conclusão “diferentes estados, diferentes padrões” fica descritiva, mas não plenamente política.

7. **A seleção do caso pode ser melhor explorada teoricamente.** O Brasil é um caso forte porque combina federalismo, universalismo constitucional, coordenação federal robusta e municipalização intensa. Mas o paper deve dizer que tipo de caso o Brasil é: típico de federações descentralizadas? Least-likely para diferenciação? Most-likely para uniformização? A melhor estratégia seria apresentar o SUS como um caso em que a literatura esperaria forte convergência; encontrar divergência na composição, portanto, torna-se teoricamente interessante.
8. **A introdução vende bem o tema, mas ainda não vende completamente o paper.** As primeiras páginas apresentam contexto e literatura, mas a contribuição poderia aparecer de forma mais incisiva até o fim da segunda página. Sugiro reorganizar a introdução em torno de um puzzle: a literatura descreve o SUS como caso de redução de desigualdades territoriais; contudo, quando se observa a composição da oferta estadual, surge diferenciação crescente. Esse contraste é o gancho teórico mais forte do artigo.

Comentários menores

1. Há inconsistência temporal: o resumo menciona 1976–2025; a conclusão menciona 1976–2024. Uniformizar.
2. “Oferta”, “provisão”, “gestão” e “titularidade” aparecem quase como sinônimos. Como os dados capturam gestão estadual de estabelecimentos, a terminologia precisa ser conceitualmente precisa.
3. A frase “Este artigo, porém, não explora os mecanismos explicativos” enfraquece demais a ambição do manuscrito. Melhor dizer que o artigo identifica padrões compatíveis com mecanismos específicos e explicita quais podem ser avaliados em pesquisas futuras.
4. A revisão de literatura é competente, mas ainda funciona mais como balanço do que como construção de argumento. Ela deveria terminar com uma proposição clara.
5. Há referências citadas no texto que parecem faltar na bibliografia final, como Arretche (2012) e Inojosa (1990). Revisar consistência.
6. Alguns gráficos estão numerados de forma repetida como “Gráfico 7” e “Gráfico 9”. Isso precisa ser corrigido.
7. O título é bom, mas poderia ficar mais teórico. Algo como “Convergência na responsabilidade, divergência na oferta” comunicaria melhor a contribuição.

Referências sugeridas

- Arretche, Marta. *Democracia, federalismo e centralização no Brasil*.
- Arretche, Marta. “Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas de

coordenação e autonomia.”

- Almeida, Maria Hermínia Tavares de. “Recentralizando a federação?”
- Souza, Celina. “Federalismo, desenho constitucional e instituições federativas no Brasil pós-1988.”
- Rodden, Jonathan. “Comparative Federalism and Decentralization: On Meaning and Measurement.”
- Falletti, Tulia. “A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective.”
- Treisman, Daniel. *The Architecture of Government: Rethinking Political Decentralization*.
- Hooghe, Liesbet, and Gary Marks. “Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance.”
- Fenwick, Tracy Beck. *Avoiding Governors: Federalism, Democracy, and Poverty Alleviation in Brazil and Argentina*.
- Shipan, Charles, and Craig Volden. “The Mechanisms of Policy Diffusion.”
- Mahoney, James, and Kathleen Thelen. *Explaining Institutional Change*.
- Paim et al. “The Brazilian Health System: History, Advances, and Challenges.”
- Castro et al. “Brazil’s Unified Health System: The First 30 Years and Prospects for the Future.”

Parecer completo — Parecerista 2 (Método & Inferência)

Recomendação: R&R major

Resumo do paper

O artigo constrói um painel UF-ano sobre estabelecimentos de saúde no Brasil, combinando AMS e CNES, para analisar a evolução da oferta estadual de serviços entre 1976 e 2025. O argumento central é que o SUS teria produzido homogeneização no peso relativo da provisão estadual, mas diferenciação crescente na composição dos serviços ofertados pelos estados.

Avaliação geral

O manuscrito tem uma base empírica promissora, uma pergunta relevante e uma contribuição potencial importante: deslocar o debate sobre federalismo e desigualdade territorial de medidas fiscais ou de cobertura para a composição concreta da oferta de serviços. O principal problema metodológico é que o desenho atual é descritivo, mas várias passagens fazem inferências causais sobre efeitos do SUS, da União e de incentivos federais. Como descrição longitudinal, o artigo é interessante; como argumento causal, ainda não identifica o contrafactual relevante. Além disso, a harmonização AMS-CNES, o uso de número de estabelecimentos como proxy de oferta e a ausência de testes de robustez precisam ser substancialmente fortalecidos.

Comentários maiores

1. **A estratégia de identificação não sustenta as alegações causais.** O artigo mostra mudanças temporais antes e depois do SUS, mas não identifica o que teria ocorrido na ausência do SUS, das NOBs ou da centralização federal. Isso é especialmente problemático quando o texto afirma que “incentivos federais reduziram” a presença estadual ou que o SUS “produz efeitos ambivalentes”. Sugestão: ou reformular explicitamente o paper como inferência descritiva, retirando linguagem causal forte, ou definir um estimando causal e um desenho compatível, por exemplo análise de interrupção temporal, testes de quebra estrutural, placebos de datas, ou variação estadual na exposição às NOBs, transferências federais, habilitação municipal ou presença estadual pré-SUS.
2. **O estimando precisa ser explicitado.** O paper alterna entre “variação territorial”, “desigualdade”, “oferta”, “presença do estado” e “composição da rede”. Essas quantidades não são equivalentes. Sugestão: declarar formalmente as quantidades-alvo: proporção estadual no total estadual+municipal, dispersão interestadual dessa proporção, vetor composicional por macrocategoria e distância média entre vetores estaduais. Isso ajudará a separar achados sobre descentralização, capacidade instalada, composição setorial e heterogeneidade territorial.
3. **A comparabilidade AMS-CNES é o principal risco de mensuração.** As bases diferem em finalidade, cobertura, granularidade e critérios administrativos. Parte da mudança observada pode refletir alteração de classificação ou registro, não mudança real na oferta. O próprio texto reconhece isso, mas a solução ainda é insuficiente para sustentar a magnitude dos resultados. Sugestão: incluir um apêndice técnico com o dicionário completo de harmonização, regras de inclusão/exclusão, anos cobertos, tratamento de missings e validações. Se houver anos de sobreposição ou proximidade entre AMS e CNES, comparar níveis e categorias para avaliar descontinuidades de mensuração.
4. **Número de estabelecimentos é uma proxy limitada para oferta de serviços.** Um posto, uma UBS, um hospital geral e um laboratório não representam a mesma capacidade instalada, custo, complexidade ou volume de atendimento. Isso afeta principalmente a interpretação da composição: estados podem parecer “especializados” em categorias baratas ou numerosas, sem que isso corresponda à capacidade real de provisão. Sugestão: no período CNES, replicar análises com leitos, profissionais, procedimentos, porte do estabelecimento, ou pesos aproximados por complexidade/custo. Caso isso não seja possível para a série completa, fazer pelo menos uma validação para 2005-2024.
5. **O denominador da variável de presença estadual precisa de justificativa mais forte.** A proporção estadual sobre estabelecimentos públicos estaduais+municipais mistura retração estadual, expansão municipal e mudanças no universo público total. O artigo melhora ao mostrar números absolutos, mas a interpretação causal ainda depende de distinguir

municipalização, criação líquida de serviços e transferência administrativa. Sugestão: decompor a variação da proporção em componentes: mudança no numerador estadual, mudança no denominador municipal e mudança líquida total.

6. **A análise composicional requer robustez própria.** A distância de Manhattan é defensável como indicador descritivo, mas dados composicionais têm restrições mecânicas: aumentos em uma categoria implicam reduções relativas em outras. Além disso, a expansão de tipos no CNES pode gerar heterogeneidade artificial. Sugestão: testar sensibilidade com distância de Jensen-Shannon, distância euclidiana, variação total, índices de entropia/HHI e, idealmente, abordagem de dados composicionais baseada em log-ratios. Também é importante reportar a escala da distância de Manhattan e sua interpretação substantiva.
7. **Faltam testes de robustez e incerteza.** O artigo depende fortemente de gráficos, mas não mostra se os padrões resistem a decisões alternativas de classificação, exclusão de casos ou escolha de anos. Sugestão: incluir análises leave-one-state-out, exclusão de DF e estados/territórios com mudanças institucionais relevantes, ponderação por população, exclusão da categoria “não-comparável”, uso apenas de categorias estritamente harmonizáveis e placebos de quebras temporais. Mesmo tratando UFs como população, há incerteza de mensuração e classificação que deve ser explorada por sensibilidade.
8. **O mecanismo causal é levantado, mas não testado.** A conclusão apresenta hipóteses plausíveis: coordenação federal da atenção primária, acúmulo de instrumentos, capacidade fiscal e complementaridade com redes municipais. Essas hipóteses são interessantes, mas hoje aparecem como interpretação pós-hoc. Sugestão: testar mecanismos observáveis com variáveis de transferências federais, gasto estadual, capacidade fiscal, cobertura municipal, densidade populacional, necessidades epidemiológicas e participação dos municípios na rede. Se isso ficar para trabalhos futuros, o artigo deve reduzir a força das conclusões causais.

Comentários menores

1. Há inconsistências temporais a corrigir: o texto menciona 1976-2025, 1976-2024, 2005-2024, 2006-2025, além de disponibilidade em 1999 e 1984-2000. É preciso padronizar anos e explicar a origem de cada ponto.
2. A numeração de figuras está confusa, com repetição de “Gráfico 7” e “Gráfico 9”. Isso dificulta a leitura técnica.
3. As figuras precisam indicar denominador, unidade, anos disponíveis, categorias incluídas e se os valores são ponderados ou não.
4. As tabelas de classificação deveriam vir com notas justificando casos ambíguos, especialmente “não-comparável”, farmácias, centrais de regulação e unidades móveis.
5. O artigo deveria apresentar uma tabela descritiva básica por período: número de UFs, total de estabelecimentos, média, mediana, desvio-padrão,

mínimo e máximo.

6. A discussão de missing data e inconsistências é honesta, mas genérica. É necessário quantificar quantos dados faltam, em quais anos, para quais UFs e como isso afeta os indicadores.
7. Se o paper mantiver linguagem de hipótese/teste, deve evitar tratar gráficos descritivos como testes confirmatórios sem critério inferencial claro.
8. O apêndice online deveria conter código replicável, fontes, data de acesso, dicionário das bases, crosswalk AMS-CNES e todas as análises de sensibilidade.

Referências sugeridas

- Lundberg, Johnson & Stewart, “What Is Your Estimand?”
- Gerring, “Mere Description”
- King, Keohane & Verba, *Designing Social Inquiry*
- Angrist & Pischke, *Mostly Harmless Econometrics*
- Imbens & Rubin, *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*
- Hernán & Robins, *Causal Inference: What If*
- Dunning, *Natural Experiments in the Social Sciences*
- Bertrand, Duflo & Mullainathan, “How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates?”
- Callaway & Sant’Anna, “Difference-in-Differences with Multiple Time Periods”
- Sun & Abraham, “Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies”
- Abadie, “Using Synthetic Controls”
- Aitchison, *The Statistical Analysis of Compositional Data*

Arquivo gerado em UTF-8. Este documento não edita o manuscrito original.